

Листовка: информация за потребителя

Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС 10 mg/25 mg филмирани таблетки

Bisoprolol/Hydrochlorothiazide-DC 10 mg/25 mg film-coated tablets

Бисопрололов фумарат/Хидрохлоротиазид

(Bisoprolol fumarate/Hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС
3. Как да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС
4. Възможни нежелани реакции:
5. Как да съхранявате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и за какво се използва

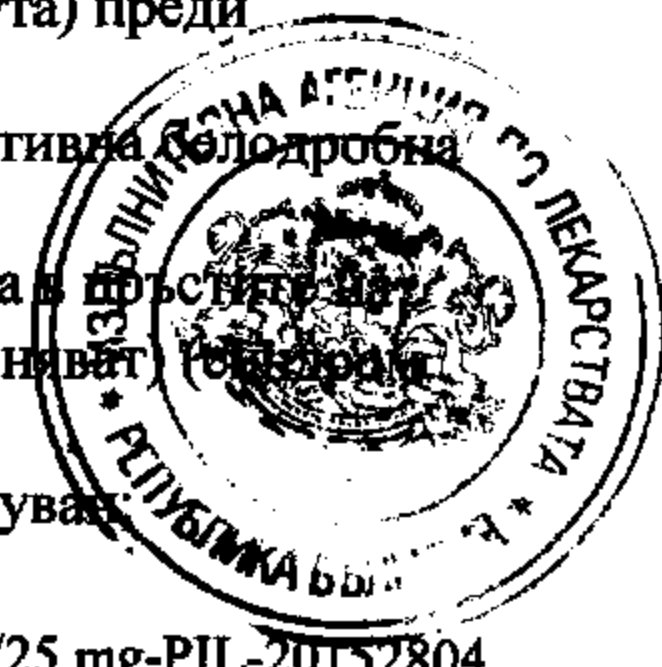
Това лекарство съдържа селективен бета-рецепторен блокер (бисопролол) и тиазиден диуретик (лекарство за елиминиране на вода от тялото) (хидрохлоротиазид).

То се използва за лечение на високо кръвно налягане (първична хипертония) при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно добре контролирано само с бисопролол или хидрохлоротиазид.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Не приемайте Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

- ако знаете, че сте свръхчувствителни (алергични) към бисопролол или хидрохлоротиазид, или други тиазиди, сулфонамиди или някоя от останалите съставки на филмираните таблетки (изброени в точка 6);
- ако имате остра сърдечна недостатъчност или влошаване (декомпенсация) на съществуваща сърдечна недостатъчност, което прави необходимо да бъдете лекувани интравенозно с вещества за усиляване на сърдечната дейност;
- ако имате шок, причинен от нарушаване на сърдечната функция (кардиогенен шок);
- ако имате сериозно нарушение на сърдечния ритъм (II^{ра} и III^{ра} степен на AV блок без пейсмейкър, синдром на болния синус, сино-атриален блок);
- ако имате много забавена сърдечна дейност (по-малко от 60 удара в минута) преди започване на лечението;
- ако имате склонност към тежка бронхиална астма или хронична обструктивна белодробна болест;
- ако имате тежки проблеми с кръвообращението (което може да е причина в пръстите на краката и ръцете Ви да се появява мравучкане или да побеляват или посиняват (периферен Рейно) на Рейно)
- ако имате тумор на надбъбречната жлеза (феохромоцитом) и той не е лекуван



- ако имате повишена киселинност на кръвта (метаболитна ацидоза);
- ако имате тежко увреждане на бъбречната функция (бъбречна недостатъчност) с малко или никаква продукция на урина (креатининов клирънс под или равен на 30 ml/минута или серумен креатинин над 159 $\mu\text{mol/l}$);
- ако имате остро възпаление на бъбрека (гломерулонефрит);
- ако боледувате от серия загуби на съзнание, причинени от сериозно чернодробно заболяване (чернодробна кома/прекома);
- ако имате недостиг на калий (хипокалиемия), който не се поддава на лечение;
- ако имате тежък дефицит на натрий (хипонатриемия);
- ако имате повишено ниво на калций (хиперкалциемия);
- ако боледувате от подагра;
- ако кърмите;
- ако приемате флоктафенин или султоприд (вижте по-долу „Други лекарства и Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС“).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС:

- ако имате сърдечна недостатъчност (лечение на стабилна хронична сърдечна недостатъчност [слабост на сърдечния мускул] трябва да започнете с постепенно повишаване само на бисопролол);
- ако боледувате от бронхиална астма или обструктивна болест на дихателните пътища;
- ако получавате едновременно и инхалационни анестетици;
- ако имате захарен диабет със силно променливи стойности на кръвната захар; симптомите на много ниска кръвна захар (хипогликемия) може да бъдат замаскирани;
- ако сте на много стриктна диета;
- по време на лечение за десенсибилизация;
- ако боледувате от леки нарушения на сърдечния ритъм (I^{ва} степен на AV блок);
- ако имате нарушено кръвоснабдяване на сърцето, причиняващо болка в гърдите и в резултат на спазматични контракции на коронарните артерии (ангина на Принцметал);
- ако имате проблеми с кръвообращението (възможно е усилване на симптомите, особено в началото на лечението);
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност (Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС не е ефикасен и може да бъде дори вреден);
- ако обемът на кръвта Ви е намален (хиповолемия);
- ако имате увреждане на чернодробната функция;
- ако сте в старческа възраст;
- ако имате прекомерно високи нива на пикочна киселина в кръвта (хиперурикемия), тъй като рискът от подагрозен пристъп може да бъде увеличен;
- ако имате или сте имали псориазис;
- ако сте имали проблем с щитовидната жлеза. Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС може да замаскира симптомите на тиреоидна свръхактивност.
- ако имате тумор на надбъбречната жлеза (феохромоцитом) и той не е лекуван.

Ако имате бронхиална астма или други хронични обструктивни нарушения на белодробната функция, които може да причиняват симптоми, може да се наложи Вашият лекар да увеличи прилаганата Ви доза бронходилататори (β_2 -симпатомиметици) докато приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС.

Не трябва да спирате лечението с β -блокери (като бисопролол) рязко, освен ако не е необходимо по спешност.

Случаи на остро възпаление на жлъчния мехур (холецистит) при пациенти с камъни в жлъчката трябва да се докладват.

Активно състезаващите се атлети трябва да знаят, че този лекарствен продукт съдържа активно вещество, което може да даде положителна реакция при тестове за допинг.



Ако носите контактни лещи, трябва да знаете, че бисопролол може да намали продукцията на сълзи.

Докато провеждате лечение с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС, трябва да пиете много течности и да ядете храна богата на калий (като банани, зеленчуци, ядки) за да покриете повишената загуба на калий.

Този лекарствен продукт може да причини кожни реакции при излагане на слънце, като обрив, зачервяване на кожата, сърбеж (това се нарича фотосенсибилизация). Ако се случи това, кожата трябва да бъде защитена от излагане на слънце (чрез слънцезащитни кремове, дрехи, избягване на слънцето). При тежки случаи на фотосенсибилизация, понякога е необходимо да се прекрати приемът на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС, но трябва първо да се консултирате с Вашия лекар.

Деца и юноши

Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС не се препоръчва при деца.

Други лекарства и Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

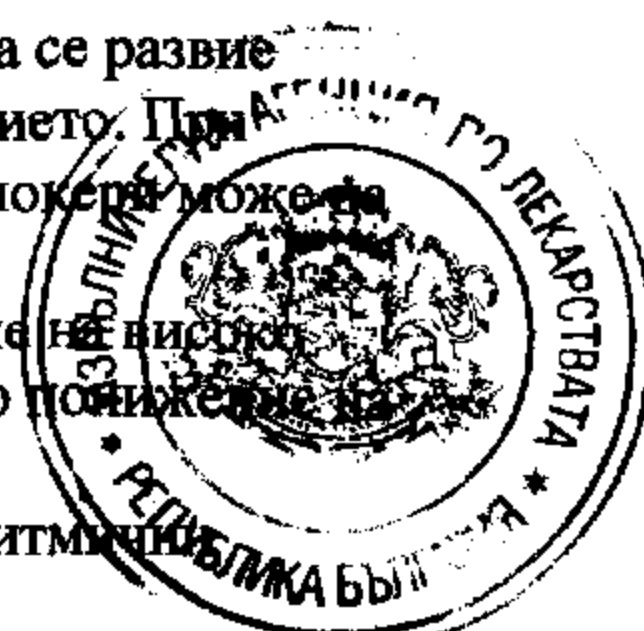
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не трябва да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС едновременно с:

- флоктафенин (използван за лечение на някои форми на артрит) или
- султоприд (използван за лечение на някои форми на психично заболяване) (вижте по-горе, „Не приемайте Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС“).

Непременно информирайте Вашия лекар, ако използвате някое от следните лекарства:

- калциеви антагонисти като верапамил или дилтиазем, които се използват за лечение на определени форми на сърдечно заболяване: може да се появят нарушения на сърдечния ритъм и слабост на сърдечния мускул.
- клонидин, който се използва за лечение на високо кръвно налягане: може да се появят прекомерно спадане на сърдечната честота и абнормен сърдечен ритъм. Спирането на клонидин може да доведе до прекомерно повишаване на кръвното налягане. Клонидин може да се прекрати само когато лечението с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС е преустановено няколко дни преди това. След това клонидин може да се спре постепенно.
- инхибитори на моноамино оксидаза (МАО) като моклобемид или фенелзин, с изключение на инхибитори на МАО-В като сележилин, които се използват за лечение на състояния като депресия: може да се развие прекомерно понижаване или повишаване на кръвното налягане.
- литий, който се използва за лечение на депресия: може да доведе до по-сериозно увреждане на сърдечносъдовата и нервната система в резултат на намаленото елиминиране на литий.
- астемизол (антихистамин), интравенозен еритромицин (антибиотик), халофорантрин (използван за лечение на малария), пентамидин (използван за лечение на паразитна инфестация), спарфлоксацин (антибиотик), терфенадин (антихистамин), винкамин (използван за лечение на определени форми на мозъчна болест): може да се развие сериозно нарушение на сърдечния ритъм.
- калциеви антагонисти като нифедипин (така наречените дихидропиридинови), които се използват за лечение на определени форми на сърдечно заболяване: може да се развие прекомерно понижаване на кръвното налягане, особено в началото на лечението. При пациенти с латентна сърдечна недостатъчност, едновременното лечение с β-блокери може да доведе до прояви на сърдечна недостатъчност.
- АСЕ инхибитори, като каптоприл и еналаприл, които се използват за лечение на високо кръвно налягане и други сърдечни състояния: може да се развие прекомерно понижаване на кръвното налягане в началото на лечението.
- лекарства използвани за лечение на нарушения на сърдечния ритъм (анти-аритмични)



- продукти) като дизопирамид, хинидин, амиодарон: ефектите на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и анти-аритмиците върху сърдечната функция може да имат добавъчен ефект. Може да се развият сериозни, потенциално фатални аномалии на сърдечния ритъм (така наречения *torsade de pointes*).
- така наречените парасимпатикомиметични лекарства, включително такрин, който се използва за лечение на болестта на Алцхаймер: може да се развие сериозно нарушение на сърдечния ритъм.
 - резерпин, α -метилдопа, гуанфакин, които се използват за лечение на състояния като високо кръвно налягане: може да се развият прекомерно спадане на кръвното налягане и сърдечната честота или абнормен сърдечен ритъм.
 - други бета-блокери, включително тези, които се съдържат в очните капки, използвани за лечение на сърдечни или очни състояния, имат добавъчен ефект.
 - инсулин или други медикаменти за намаляване на кръвната захар (сулфонилуреи), които се използват при лечение на диабет: ефектите на тези лекарства може да се усилят. Предупредителни прояви на понижена кръвна захар (хипогликемия) – особено ускорен пулс (тахикардия) – може да бъдат замаскирани или по-слабо проявени.
 - анестетици: може да се появи с повишена честота понижено на кръвното налягане. Преди да се подложите на обща анестезия, Вашият анестезиолог трябва да бъде информиран/а за Вашето лечение с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС.
 - лекарства като дигиталисови препарати, които се използват за лечение на сърдечни състояния като застойна сърдечна недостатъчност: всеки дефицит на калий или магнезий прави по-вероятно развитието на нежелани реакции при приемането на дигиталис.
 - инхибитори на простагландиновата синтеза като ацетилсалицилова киселина (аспирин), който може да се използва за облекчаване на болка: понижаващият кръвното налягане ефект на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС може да бъде по-слаб. Страничните ефекти на високи дози подобни на аспирин лекарства (салицилати) върху нервната система може да бъде повишен.
 - нестероидни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен, които може да се използват за облекчаване на болка: при пациенти с намален кръвен обем (хиповолемия), може да се развие бъбречна недостатъчност.
 - ерготаминови производни като бромокриптин, които се използват за лечение на състояния, като болестта на Паркинсон: всякакви съществуващи нарушения на кръвообращението могат да се влошат.
 - така наречените симпатомиметични лекарства като фенилефрин, метилдопа, добутамин или салбутамол, които може да се използват за лечение на сърдечни състояния, като високо кръвно налягане или астма: може да се развие отслабване на ефектите и на двете лечения.
 - трициклични антидепресанти като амитриптилин, барбитурати като фенотиазин, фенотиазини като хлорпромазин, които се използват за лечение на състояния като депресия, и други лекарства, които намаляват кръвното налягане: възможен е усилен ефект по отношение на намаляване на кръвното налягане.
 - рифампицин, антибиотик: ефектът на бисопролол ще бъде по-краткотраен. Обикновено не е необходимо да се коригира дозата.
 - ефектът на медикаменти, които намаляват пикочната киселина може да бъде отслабен, ако приемате едновременно Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС.
 - глюкокортикостероиди, като хидрокортизон или дексаметазон (използвани за лечение на възпаление), АСТН (използван за лечение на множествена склероза или ревматоиден артрит), карбеноксолон (използван за лечение на язви), амфотерицин В (антибиотик), фуросемид (диуретик, или „таблетка за уриниране“) или лаксативи: може да бъде увеличена загубата на калий.
 - ефектът на кураре-подобни мускулни релаксанти като тубокурарин, може да бъде усилен или удължен, ако едновременно приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС.
 - цитостатици (напр. циклофосфамид, флуороурацил, метотрексат), които може да се използват за лечение на рак: може да се очаква повишена костно-мозъчна токсичност.
 - холестирамин, коlestипол, които може да се използват за лечение на повишен холестерол:



- тези лекарства намаляват количеството абсорбиран хидрохлоротиазид.
- метилдопа, който може да се използва за лечение на високо кръвно налягане: в изолирани случаи се съобщава за хемолиза (повишен хемоглобин в кръвта, тъй като се отделя от червените кръвни клетки) в резултат на формиране на антитела срещу хидрохлоротиазид.
 - мефлоквин, който се използва за лечение на малария: рискът от спадане на сърдечната честота се повишава.
 - циметидин, който може да се използва за лечение на язви на стомашно-чревния тракт: ефектът на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС може да се усили.

Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС с храна и напитки

Трябва да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС сутрин по време на закуска, ако това е възможно.

По време на лечение с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС, трябва непременно да пиете достатъчно течности и да ядете храна богата на калий (като банани, зеленчуци, ядки), за да покриете повишената загуба на калий.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че сте бременна. Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да вземате друго лекарство на мястото на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС, тъй като той не се препоръчва по време на бременност. Причината за това е, че Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС преминава през плацентата и неговата употреба след третия месец на бременността може да причини потенциално опасни за плода и новороденото ефекти.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако кърмите или Ви предстои да започнете да кърмите. Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС не се препоръчва за майки, които кърмят.

Шофиране и работа с машини

Макар че Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС обикновено няма ефект върху способността да шофирате или да работите с машини, трябва да внимавате, когато сте ангажирани с подобни дейности, особено в началото на лечението, ако лечението Ви се промени, или ако сте консумирали алкохол. Понякога при употреба на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС може да се появи замаяване.

3. Как да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Винаги приемайте това лекарство точно както ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Перорално приложение.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Трябва да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС сутрин по време на закуска, ако това е възможно, и трябва да я гълтате цяла, без да я дъвчете, с малко течност.

Препоръчва се индивидуална корекция на дозата по отношение на активните вещества (т.е. бисопролол и хидрохлоротиазид).

Ако Вашият лекар счита, че е оправдано, възможно е директно преминаване от монотерапия към фиксирана комбинация.



Обичайната доза е една таблетка от 5 mg/12,5 mg или половината от 10 mg/25 mg един път дневно. Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на две таблетки от 5 mg/12,5 mg или една таблетка от 10 mg/25 mg един път дневно, в зависимост от Вашия отговор на лечението.

Вашият лекар ще реши колко продължително трябва да бъде лечението Ви.

Пациенти с бъбречно заболяване, пациенти в старческа възраст

Вашият лекар ще определи дозата, която е най-подходяща за Вас (вижте също по-горе „2 Какво трябва да знаете преди да приемете Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС“)

Употреба при деца

Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС не се препоръчва при деца, тъй като няма клиничен опит при тях.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Потърсете медицинска помощ. Вашият лекар може да определи мерките, които може да са необходими, в зависимост от размера на предозирането. В случай на предозиране, трябва да спрете лечението си с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС.

Най-честите прояви на предозиране на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС са забавена сърдечна дейност (брадикардия), затруднено дишане (bronхоспазм), тежко спадане на кръвното налягане, остра сърдечна недостатъчност и ниска кръвна захар (хипогликемия).

Ако сте пропуснали да приемете Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Продължете да приемате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС съгласно инструкциите в листовката или както Ви е предписал Вашият лекар.

Ако сте спрели приема на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Не прекъсвайте и не спирайте лечението с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС, без да обсъдите това предварително с Вашия лекар.

Не трябва да спирате Вашето лечение с Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС внезапно, тъй като това може да влоши сърдечната недостатъчност. Вашето лечение трябва да бъде спряно постепенно (чрез намаляване дозата на половина през интервал от 7-10 дни), тъй като рязкото спиране на лечението може да доведе до остро влошаване на Вашето състояние.

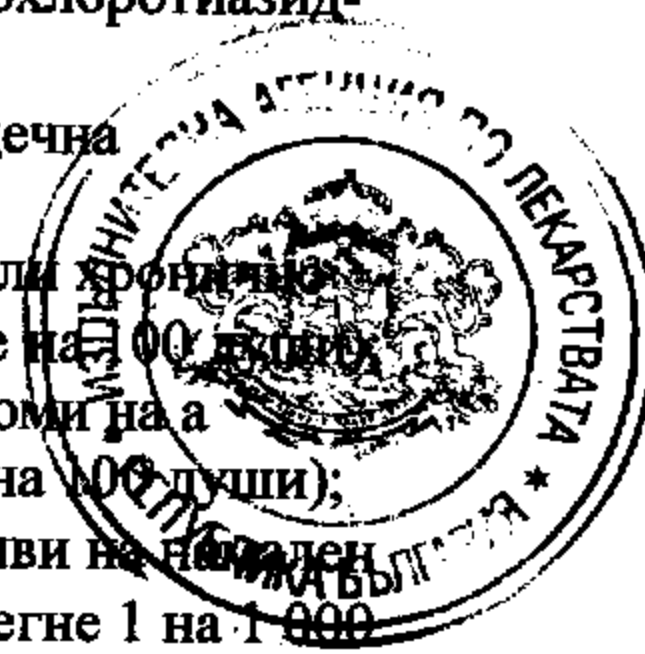
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако почувствате някой от следните симптоми, спрете приема на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и незабавно посетете Вашия лекар или най-близката болница:

- обострен задух и оток на крайниците, което е симптом на влошаваща се сърдечна недостатъчност (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 100 души);
- проблеми с дишането и хрипове (bronхоспазм), особено ако имате астма или хронично заболяване на дихателните пътища (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 100 души);
- силна болка в корема и гърба, с общо неразположение може да бъдат симптоми на а състояние, наречено панкреатит (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 100 души);
- грипоподобни симптоми и повишена температура, което може да бъдат прояви на възможен брой бели кръвни клетки (левкопения) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 1 000 души).



души);

- лесно кръвонасядане или кървене, което може да бъде симптом на нисък брой кръвни плочици (тромбоцитопения) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 1 000 души);
- болка в корема, загуба на апетит, пожълтяване на бялото на очите и кожата с тъмна урина, което може да бъде причинено от възпаление на черния дроб (хепатит) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 1 000 души);
- пожълтяване на кожата и очите (жълтеница) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 1 000 души);
- алергични реакции: сърбеж, зачервяване на кожата, обрив, реакции на чувствителност на светлина (фотодермия), кървене в кожата (пурпура), уртики (уртикария) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 1 000 души);
- болка в гърдите (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 10 000 души);
- псориазис (състояние, при което в кожата се развиват сребристи плаки) или подобен на псориазис обрив, влошаване на съществуващ псориазис (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 10 000 души);
- кожни състояния с червени белези се плаки върху носа и бузите (лупус еритематодес) (тази нежелана реакция може да засегне 1 на 10 000 души);

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

- някой нежелани реакции може да се наблюдават само при кръвни изследвания, като повишаване нивата на серумните масти (триглицериди, холестерол), повишена кръвна захар (хипергликемия) и повишени нива на серумна пикочна киселина (хиперурикемия, което може да е свързано с подагра);
- екскреция на захар в урината (глюкозурия);
- нарушение на водното и електролитно равновесие, особено намалени нива на серумен калий (хипокалиемия, което може да причини умора, изтощение, мускулна слабост, абнормни усещания в крайниците (парестезия), парализа, апатия, слабост на гладката мускулатура със запек, прекомерно натрупване на газ в стомашно-чревния тракт (флатуленция), или нарушен сърдечен ритъм, чревно запушване, нарушение на съзнанието и кома);
- и намалени нива на серумен натрий (хипонатриемия, което може да причини умора и объркване, мускулни спазми, припадъци и кома); намалени нива на серумен магнезий (хипомагнезиемия, което може да се свързва с мускулни проблеми), намалени нива на серумен хлор (хипохлоремия)
- повишени нива на серумен калций (хиперкалциемия, причиняващи коремна болка, усещане за гадене и гадене, запек, загуба на апетит, прекомерна жажда, прекомерно уриниране, умора, слабост и загуба на тегло);
- повишена киселинност на кръвта (метаболическа ацидоза, което може да се свързва с отпадналост, гадене, повръщане, ускорено дишане);
- умора*
- замаяване*
- главоболие*
- усещане за изстиване или изтръпване на крайниците;
- гадене, повръщане, диария, запек.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

- изтощение*
- загуба на апетит
- нарушен сън
- депресия
- забавена сърдечна дейност (брадикардия)
- нарушения на сърдечния ритъм (наречени нарушения на AV проводимостта)
- ниско кръвно налягане, което може да възникне при промени в позата и може да се характеризира с усещане за замаяване и слабост, когато се изправите от седнало положение (ортостатична хипотония);



- загуба на апетит;
- коремна болка;
- някои нежелани реакции може да се наблюдават при кръвни изследвания: повишаване на определени молекули в кръвта (амилаза, креатинин и урея);
- мускулна слабост и крампи.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

- кошмари, халюцинации;
- намалено сълзене (да се има пред вид при употреба на очни лещи);
- визуални смущения;
- проблеми със слуха;
- алергичен ринит (носна секреция);
- някои нежелани реакции може да се наблюдават само при кръвни изследвания: повишаване на определени чернодробни ензими в кръвта (ALT, AST);
- импотентност.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

- намален брой гранулоцити в кръвта (агранулоцитоза, което може да се прояви с грипоподобни симптоми и повишена температура) – ако се чувствате така, спрете приема на Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и незабавно посетете Вашия лекар или най-близката болница;
- някои нежелани реакции може да се наблюдават само при кръвни изследвания, като метаболитна алкалоза;
- конюнктивит (възпаление на лигавицата около окото);
- загуба на слух.

* Тези прояви и симптоми се появяват най-вече в началото на лечението. Те са обикновено леки и най-често преминават за 1 до 2 седмици.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

Да се съхранява под 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху етикета след „Годен до:“.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС

- Активните вещества са бисопрололов фумарат и хидрохлоротиазид.

Всяка таблетка съдържа 10 mg бисопрололов фумарат и 25 mg хидрохлоротиазид.

- Другите съставки са:

Царевично нишесте, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, калций



хидрогенфосфат, безводен, магнезиев стеарат, хипромелоза, полисорбат 80, макрогол 400, брилянтно синьо FCF алуминий (E133), хинолин жълт алуминиев лак (E104) и титанов диоксид (E171).

Как изглежда Бисопролол/Хидрохлоротиазид-ДС и какво съдържа опаковката

Вашите таблетки са сини, филмирани кръгли таблетки, с делителна черта и напечатано „В“ от лявата страна на чертата и „Н“ от дясната страна на чертата. На другата страна на таблетката е отпечатано „10“. Те се предлагат в опаковки с блистери, съдържащи 28, 30, 50, 56 и 100 таблетки.

Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Dema Consult s.r.o.

Slunná 16, 617 00 Brno

Чешка република

Производител

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

